

Positionnement fondateur

« La santé n'est pas un marché, c'est un lien entre l'État et ses citoyens. »

« On ne repart pas de zéro, on change le moteur sans changer la voiture. »

« On ne détruit pas des emplois, on les transforme au service du public. »

1, Le modèle Beveridgien, définition et vision

Qu'est-ce que le modèle Beveridgien ?

Il existe deux grands modèles de protection sociale dans le monde. Le modèle Bismarckien, système actuel français, finance la santé par des cotisations liées au travail. Si vous travaillez vous êtes protégé, si vous ne travaillez pas vous l'êtes moins. C'est un système lié à l'emploi, inégalitaire par nature.

Le modèle Beveridgien, du nom de l'économiste britannique William Beveridge qui l'a théorisé en 1942, finance la protection sociale par l'impôt. Tout citoyen est couvert identiquement, qu'il travaille ou non, qu'il soit riche ou pauvre. C'est le modèle des pays nordiques, Finlande, Norvège, Danemark, qui obtiennent les meilleurs résultats de santé au monde.

La France est aujourd'hui à mi-chemin entre les deux, un système hybride coûteux administrativement, illisible pour les citoyens et inégalitaire dans ses effets. Les LFP proposent le basculement progressif vers le modèle Beveridgien.

Ce que ça change concrètement

- Couverture santé universelle, salarié, auto-entrepreneur, chômeur, sans emploi, tous couverts identiquement
- Financement par l'impôt, recettes des nationalisations, ISF rénové, FNDR
- Suppression du tiers payant généralisé devenu inutile, économie administrative directe
- Suppression de la Complémentaire Solidaire de Santé, plus d'inégalités à corriger à la source
- En supprimant les inégalités à la source on supprime le coût des mesures qui venaient les corriger

Qui est couvert ?

Sont couverts par la couverture universelle tous ceux qui contribuent au système fiscal français, résidents en France payant leurs impôts en France, quel que soit leur statut. Un étranger en situation régulière qui travaille et cotise en France est couvert comme tout citoyen.

Ne sont pas couverts par la couverture complète les exilés fiscaux, personnes physiquement absentes de France et ne payant pas d'impôts en France. Un exilé fiscal qui revient en France se faire soigner sans avoir contribué au système ne bénéficie pas de la couverture universelle. En 10 ans c'est un actif de près de 24 milliards d'euros imposables qui a échappé au fisc français, ce manque à gagner se répercute directement sur le

financement du système de santé. (Source : Boursorama, rapport Marini, 2019)

Maintenues pour tous sans exception :

- AME, Aide Médicale d'État, pour les sans-papiers et demandeurs d'asile : 1,2 milliard d'euros en 2024. (Source : Sénat, rapport Delahaye, novembre 2023)
- Soins d'urgence vitaux pour tout être humain sur le sol français, le serment d'Hippocrate s'applique sans condition

« On ne laisse pas mourir quelqu'un dans la rue, mais on ne soigne pas gratuitement ceux qui ont choisi de ne pas contribuer. »

Financement, affectation fléchée de l'ISF rénové

Les recettes de l'ISF rénové, estimées entre 6 et 10 milliards d'euros par an, sont affectées directement et exclusivement aux hôpitaux publics : matériel médical, formation des soignants, rénovation des bâtiments hospitaliers, recherche médicale. Ces recettes ne passent pas dans la caisse générale de l'État. C'est une affectation fléchée et transparente, les contribuables savent exactement à quoi sert cet impôt.

2, Reconversion des mutuelles et complémentaires

La disparition des mutuelles et complémentaires santé privées détruirait des centaines de milliers d'emplois, ce risque est assumé et anticipé. Les mutuelles et complémentaires sont invitées à se reconvertir en agences publiques d'information et d'accompagnement santé, extensions de la Sécurité Sociale rénovée.

Nouveau rôle :

- Information des citoyens sur leurs droits de santé
- Explication de la couverture universelle
- Accompagnement administratif des patients
- Interface de proximité entre citoyens et Sécurité Sociale

Pour les dirigeants, deux options : accepter un contrat administratif d'État attractif → conserver leur rôle de gestionnaire sous tutelle publique, céder leurs parts à l'État. Refuser → liberté de partir et créer des structures privées concurrentes sans embarquer leurs employés.

Ce qui disparaît : les remboursements partiels calculés pour gratter, optique à 30%, dentaire à 50%, franchises complexes, petits caractères des contrats. Ce qui apparaît : un rapprochement État-citoyen, transparence totale sur la couverture.

3, Réouverture des lits hospitaliers et revalorisation des soignants

La France a perdu des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux sur 30 ans, accéléré pendant le Covid. On a réduit l'offre sans réduire la demande. Les soignants étaient dans la rue pour dénoncer cette absurdité comptable qui coûte plus cher à terme via des urgences saturées.

- Réouverture progressive des lits fermés, financement via le FNDR et l'ISF rénové fléché

- Revalorisation des soignants, grille salariale unifiée : 2000 à 2 700€ nets minimum en début de carrière pour infirmiers, aides-soignants, personnels paramédicaux
- CDI direct, fin de la précarité contractuelle dans les métiers du soin
- Recrutement massif pour combler les effectifs manquants

« On ne peut pas demander à des gens de soigner les autres en les payant sous le seuil de pauvreté. »

4, Lutte contre les déserts médicaux

Des territoires entiers n'ont plus accès à des soins de proximité. La logique libérale a concentré les médecins dans les zones rentables au détriment des zones fragiles.

- Création de maisons de santé de proximité financées par l'État dans toutes les zones sous-dotées
- Médecins généralistes, infirmiers, spécialistes en rotation, présence régulière garantie
- Mesures de soutien attractives pour les professionnels qui s'installent dans les déserts médicaux, aide au logement, prime d'installation, allègement fiscal les premières années
- Même logique pour les professionnels de santé mentale, présence garantie sur tout le territoire
- L'État aide les communes à petits budgets à se développer positivement, à terme moins de contraintes et plus d'attractivité pour les professionnels de santé

5, Santé mentale

La santé mentale est le parent pauvre du système de santé français. Les listes d'attente chez les psychiatres atteignent 6 mois dans certaines régions. Le burn-out, la dépression et les troubles anxieux explosent depuis le Covid. Les professionnels sont épuisés et sous-payés.

- Remboursement de 20 séances chez un psychologue, prise en charge intégrée dans la couverture universelle, remboursement à 100% et renouvelable par avis du médecin.
- Présence garantie de professionnels de santé mentale sur tout le territoire, psychologues, psychiatres, infirmiers en psychiatrie, mêmes mesures d'attractivité que pour les médecins généralistes
- Revalorisation des soignants en psychiatrie, dans la grille unifiée 2000 à 2 700€ nets
- Centres de santé mentale de proximité, sur le modèle des maisons de santé, dans les zones sous-dotées
- Bilan psychologique de prévention : Intégration systématique d'une consultation de prévention de santé mentale lors des bilans nationaux obligatoires aux âges clés de la vie (6ème, 25 ans, 45 ans, 65 ans).

« La santé mentale n'est pas un luxe, c'est une composante de la santé tout court. »

6, Prévention, agir avant de soigner

Campagnes de prévention nationale

Sur le modèle des campagnes tabac, alcool, sécurité routière, campagnes publicitaires nationales régulières sur les grandes causes de mortalité évitable : cancer, maladies cardiovasculaires, IST, obésité, diabète, santé mentale. Financées par le FNDR.

Éducation à la santé au collège

Intégrée à l'après-midi d'éducation à la santé et à la sexualité posée dans le volet Éducation, une après-midi banalisée complète par trimestre plutôt que plusieurs petits créneaux qui empièteraient sur le nouveau rythme scolaire. Contenu : nutrition, activité physique, hygiène, IST, santé mentale, dépistages. À partir de la 5ème, en même temps que l'éducation sexuelle.

Dépistages obligatoires, liste exhaustive

Convocation automatique par la CPAM selon l'âge et le profil. Journée employeur obligatoire : toute convocation à un dépistage obligatoire donne droit à une journée d'absence rémunérée à 100% par l'employeur, zéro perte de salaire. Résultats intégrés au dossier médical partagé numérique.

Dès la naissance, dépistage néonatal

- Maladies métaboliques, mucoviscidose, hypothyroïdie, drépanocytose, élargi depuis novembre 2024

Enfance, bilan entrée en 6ème

- Bilan de santé général, troubles visuels, auditifs, posturaux
- Intégré à l'après-midi d'éducation à la santé

Adultes actifs, dès 25 ans

- IST, VIH, syphilis, hépatites B et C → tous les 2 ans pour les personnes actives sexuellement
- Cancer du col de l'utérus → femmes 25-65 ans, tous les 3 à 5 ans, frottis ou test HPV. Taux de couverture actuel : 59,5%, insuffisant. (Source : Santé Publique France, 2024)

Adultes, 40-45 ans

- Cholestérol et dyslipidémie → dès 40 ans homme, 45 ans femme
- Hypertension artérielle → tous les 2 ans dès 40 ans
- Diabète type 2 → dès 45 ans ou avant en cas de surpoids ou antécédents familiaux
- Cancer de la prostate → hommes dès 50 ans, tous les 2 ans

Adultes, 50 à 74 ans

- Cancer du sein → femmes 50-74 ans, mammographie tous les 2 ans
- Cancer colorectal → hommes et femmes 50-74 ans, tous les 2 ans. Taux de participation actuel : 34,2% contre 45% recommandé en Europe. (Source : Santé Publique France, 2024)

Seniors, dès 65 ans

- Troubles cognitifs et Alzheimer → dès 65 ans ou en cas de signes évocateurs
- Ostéoporose → femmes ménopausées et hommes dès 70 ans
- Dépistage cardiovasculaire renforcé → tous les ans

Coût estimé du programme complet : 1,5 à 2 milliards d'euros par an. Financé par la couverture universelle Beveridgienne et partiellement par l'ISF rénové fléché vers les hôpitaux. (Source : calcul LFP basé sur Assurance Maladie, rapport charges et produits 2024)

7, Réforme de la MDPH, reconnaître le vrai handicap

Principe fondateur

Sont reconnus par la MDPH, en handicap total ou partiel, uniquement les handicaps d'origine génétique, biologique ou accidentelle. La définition est limitée à ces trois catégories et ne peut être élargie que par le Parlement, pas par un arrêté ministériel ou une décision technique.

« On reconnaît ce qu'on ne choisit pas, on accompagne ce qu'on peut changer. »

Gouvernance, rôle de la HAS

La Haute Autorité de Santé est mandatée pour établir et mettre à jour les listes précises des handicaps reconnus, partiels et non reconnus dans le cadre défini par la loi LFP.

- La HAS peut : ajouter de nouveaux handicaps reconnus ou partiels au fil des découvertes médicales dans les trois catégories, génétique, biologique, accidentelle
- La HAS ne peut pas : réintégrer dans les listes reconnues les pathologies explicitement classées liées au mode de vie par la loi LFP
- Seul le Parlement peut modifier la liste des pathologies non reconnues, avec débat public, vote et justification scientifique

Handicaps non reconnus, causalité liée au mode de vie

Ces pathologies relèvent d'un accompagnement de remise en forme, pas d'une reconnaissance de handicap :

- Obésité liée à la sédentarité et la malbouffe
- Diabète de type 2
- Apnée du sommeil liée à l'obésité
- Arthrose liée au surpoids
- Burnout sans pathologie psychiatrique avérée → accompagnement thérapeutique
- Dépendances, alcool, tabac, drogues → allocation réduite de 50%, soins d'urgence maintenus, aide complète rétablie dès entrée dans le programme de sevrage et réinsertion

Même si des dommages irréversibles apparaissent à terme, la causalité initiale reste déterminante pour la non-reconnaissance. La liste est exhaustive et ne peut être élargie

que par le Parlement.

Handicaps partiels reconnus, compatibles avec le travail

Ces pathologies sont reconnues mais n'empêchent pas de travailler. L'aide MDPH est modulée, réduite de 30 à 50% par rapport à un handicap total. L'employeur a l'obligation d'aménager le poste de travail. La recherche médicale sur ces pathologies est priorisée et financée par le FNDR et l'ISF rénové.

- Endométriose, pathologie féminine longtemps sous-diagnostiquée, douloureuse mais compatible avec le travail avec aménagements
- Fibromyalgie
- Sclérose en plaques à stade précoce
- Troubles dys, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie
- TDAH
- Troubles anxieux chroniques documentés
- Syndrome fémoro-patellaire d'origine morphologique ou génétique, compatible avec le travail avec aménagements, aide MDPH modulée selon le degré d'atteinte
- Surdit   partielle
- D  ficience visuelle partielle corrigeable
- Liste compl  t  e et mise    jour par la HAS dans les trois cat  gories autoris  es

Acc  l  ration de la recherche sur les maladies sous-diagnostiqu  es, en particulier les pathologies f  minines comme l'endom  triose qui touche 10% des femmes et a mis des d  cennies      tre reconnue. Financ  e par le FNDR.

8, La Charte des Ambulanciers de France

La Charte Romain Jacob existe depuis 2013-2014, port  e par l'association Handidactique, plus de 7000 signataires dont la pr  sidence de la R  publique. Elle reste aujourd'hui un engagement volontaire, sans cons  quence juridique en cas de manquement. Les LFP la rendent opposable pour le secteur du transport sanitaire, en conditionnant l'agr  ment des entreprises et la carte professionnelle des ambulanciers au respect de ses principes, d  clin  s ici article par article en obligations concr  tes.

Un Ordre des Ambulanciers de France

Sur le mod  le de l'Ordre des m  decins, un Ordre des Ambulanciers de France est cr   , charg   de la d  ontologie de la profession, de l'instruction des manquements et des d  cisions disciplinaires. Sa cr  ation tire les le  ons de l'  chec partiel de l'Ordre national des infirmiers, cr    en 2006, dont la cotisation individuelle obligatoire a   t   per  ue comme une charge de payer pour travailler, provoquant le refus de la majorit   de la profession dix ans encore apr  s sa cr  ation.

- Financement de l'Ordre int  gr      l'agr  ment des entreprises de transport sanitaire, pas de cotisation individuelle obligatoire pesant sur chaque ambulancier
- Consultation de la profession en amont de sa mise en place, pour garantir une adh  sion de terrain plut  t qu'un dispositif impos  

Article 1, valoriser l'image que la personne perçoit d'elle-même

L'État finance des auxiliaires de vie attitrés qui interviennent dans les ménages modestes et moyens, selon le principe des sans-trous déjà posé dans le programme. Une formation à l'apprentissage du fonctionnement du corps et à des activités adaptées est proposée aux enfants en situation de handicap, pour construire une image de soi positive dès le plus jeune âge.

Article 2, exprimer les besoins et intégrer la santé au parcours de vie

Les communes et les régions coopèrent au développement et à l'installation d'associations d'accompagnement du handicap. Ces associations ont pour mission de soumettre des projets de rénovation des infrastructures publiques, écoles, transports, de mettre en place des activités, et de servir d'appui aux candidatures d'emploi et à l'adaptabilité des entreprises.

Article 3, exprimer les besoins

Une plateforme numérique régionale regroupe les requêtes des personnes en situation de handicap pour l'amélioration des aménagements, et les transmet aux autorités publiques compétentes.

Article 4, intégrer la santé au parcours de vie

Cet article rejoint directement l'article 1, les auxiliaires de vie attitrés et la formation au fonctionnement du corps s'inscrivent dans la durée du parcours de vie, pas comme des interventions ponctuelles.

Article 5, construire une culture professionnelle commune

En établissement hospitalier, une formation stricte est dispensée en interne, avec un roulement d'équipes régulier sur les soins quotidiens pour éviter l'usure et maintenir la vigilance. Pour les centres d'accompagnement à domicile, une coopération est mise en place avec les établissements de soins auxiliaires de proximité et locaux.

Article 6, coordonner le parcours de santé

Les équipes pluridisciplinaires sont reliées entre elles pour fournir un meilleur accès aux soins et aux besoins psychologiques de la personne, évitant les ruptures de parcours entre les différents intervenants.

Article 7, améliorer l'accueil et la réponse aux urgences

Des ailes spécialisées sont créées dans les établissements hospitaliers, salles d'attente équipées, chambres adaptées. Les infirmiers et médecins reçoivent une formation courte aux bons gestes et au bon langage envers les personnes en situation de handicap. Un psychologue de référence par établissement ou groupement hospitalier conçoit le protocole d'accueil, forme les équipes et reste disponible en soutien pour les situations les plus sensibles, sans exiger un diplôme complet de chaque agent d'accueil.

Le protocole d'évaluation

Une fois l'ambulancier reparti, l'équipe d'accueil de l'hôpital recense si le trajet s'est bien passé au moyen d'un questionnaire, rempli avec la personne prise en charge puis relu et corrigé si besoin par elle. Le format du questionnaire est accessible, version Facile à Lire et à Comprendre, pictogrammes, possibilité qu'un aidant ou accompagnant remplisse le document avec la personne plutôt qu'à sa place. Chaque relevé est transmis à un agent

régional pour analyse.

Le système progressif de sanction

Les manquements documentés donnent lieu à un blâme. Après trois blâmes, l'Ordre des Ambulanciers de France statue sur une décision radicale, suspension ou retrait de la carte professionnelle, après une procédure contradictoire permettant à l'agent mis en cause de se défendre. Les bons comportements, documentés de la même façon, sont récompensés par une prime d'État.

Article 8, faciliter et développer l'accès aux soins ambulatoires

Les communes transmettent aux régions un rapport agrégé et anonymisé sur le nombre de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite sur leur territoire. Les régions coordonnent avec les hôpitaux pour qu'une orientation hospitalière par défaut soit proposée automatiquement à chaque personne concernée, allégeant la lourdeur administrative. Cette orientation reste un choix, la personne peut la refuser ou la modifier, dans le respect du choix du lieu de vie que protège la charte.

Article 9, prévenir et adapter l'hospitalisation

Des bâtiments communaux et régionaux vides sont aménagés, et de nouvelles bâtisses sont construites si nécessaire, pour l'accueil, le soin, et l'absorption d'une possible surcharge hospitalière. Le financement mobilise le Protocole de Coopération Républicaine posé dans le volet Économie, don, crédit d'impôt sur la main d'œuvre, valorisation du bénévolat qualifié, label Entreprise citoyenne de la République, en complément d'une enveloppe résiduelle de 500 millions à 1 milliard d'euros portée par le budget santé, avancée puis remboursée au fur et à mesure de la collecte du FNDR.

Article 10, améliorer la réponse aux urgences médicales

Un pôle SMUR est implanté dans la plus grande ville de chaque ancien département, une échelle de couverture conservée malgré la suppression de l'échelon administratif départemental, pour garantir une capacité d'intervention sur tout le territoire.

Article 11, faciliter le recours aux technologies de l'information et de la communication

L'État s'engage à fournir un équipement technologique adapté à la condition de chaque personne, dispositifs pour personnes aveugles, équipements adaptés aux membres manquants, ou équipement standard pour les personnes non concernées par un besoin spécifique.

Article 12, mettre en œuvre et évaluer la présente charte

Chaque ambulancier de France prête serment à son entrée dans la profession :

« Je m'engage à chérir mes patients sans mépris ni humiliation. Je suis là pour aider et écouter. Je jure de ne pas faire défaut au présent code déontologique et de me soumettre aux principes qu'il définit. »

L'Ordre des Ambulanciers de France se réunit annuellement en comité pour évaluer l'application de la charte, et transmet ses travaux à la Haute Autorité de Santé, à la Conférence Nationale de Santé, et au Conseil National Consultatif des Personnes en situation de handicap.

Priorité aux secteurs en tension

Les zones identifiées comme déserts médicaux ou en tension de couverture sanitaire bénéficient d'une priorité d'implantation pour les pôles SMUR, les ailes spécialisées hospitalières, et les bâtiments aménagés au titre de l'article 9.

« Ce n'est pas à des personnes déjà éprouvées par la dépendance qu'il revient de porter, en plus, le poids du mépris. »

9, Plan sport obligatoire, zéro sédentarité

Pour qui

Toute personne dont le handicap ou la pathologie est classé dans la catégorie liée au mode de vie est orientée vers un programme de remise en forme obligatoire prescrit par le médecin traitant. Ce n'est pas une punition, c'est un traitement. L'objectif est la guérison, pas la compensation.

Organisation

- Prescription par le médecin traitant, avec suivi régulier
- Encadrement par un coach sportif médical + soutien des associations partenaires
- Salles conventionnées mises à disposition par les communes, 3 séances par semaine hors weekend et vacances scolaires
- Seuil de mise à disposition selon la taille de la commune : moins de 5 000 habitants → salle partagée avec communes voisines ; 5 000 à 20 000 habitants → 1 salle dédiée ; au-dessus de 20 000 habitants → plusieurs salles selon la population
- Durée : jusqu'à disparition des symptômes, évaluation médicale régulière
- Le droit peut s'étendre à celui du travail, proposé comme option, tout employeurs devra aménager les horaires des salariés ayant coché l'option. Évidemment les sanctions s'appliquent pour éviter le « je débauche, je rentre ».

Sanctions en cas d'absences répétées

Au-delà de 3 absences consécutives dans le mois sans motif grave justifié par un médecin :

- Personne en emploi → prise sur salaire de 100€
- Personne en réinsertion sans emploi → retenue de 20% sur le RSA ou l'aide de réinsertion jusqu'à reprise de la participation
- Personne retraitée → retenue de 50€ sur la pension

La sanction est incitative, pas punitive, elle disparaît dès que la participation reprend. Motif grave personnel avec justificatif médical → exemption totale.

10, Suppression de l'obligation alimentaire pour enfants victimes

L'article 205 du Code civil, héritage du droit napoléonien, oblige les enfants à contribuer aux soins de leurs parents même quand ces parents les ont abandonnés, violés ou

agressés. C'est une violence juridique supplémentaire infligée aux victimes.

Les LFP suppriment cette obligation dès lors que l'abandon, les violences ou les agressions sont prouvés judiciairement. Le mécanisme de suppression :

- Faits prouvés judiciairement, condamnation pénale, décision de placement, jugement civil → dossier transmis à la région
- La région vérifie et valide → exemption automatique de l'obligation alimentaire
- Pas de nouveau tribunal, pas de procédure supplémentaire, la preuve judiciaire existante suffit
- Les soins des parents sont pris en charge par la couverture universelle Beveridgienne, pas par leurs enfants victimes

Dans notre système de couverture universelle cette mesure est naturellement cohérente, tout le monde est soigné par le système, pas par sa famille.

11, FNDR et discipline budgétaire

Le Fonds National de Développement Républicain finance l'ensemble des mesures de ce volet, maisons de santé, réouverture des lits, revalorisation des soignants, dépistages, plan sport, recherche médicale. L'ISF rénové est fléché spécifiquement vers les hôpitaux publics.

Contrainte budgétaire maintenue : une part des recettes du fonds est réservée au remboursement de la dette, la discipline budgétaire est un engagement non négociable des Fraternels Phrygiens. Le fonds national ne peut pas tout absorber, la rigueur dans les priorités est maintenue.

« La santé d'une nation se mesure à celle du plus fragile de ses citoyens. »